

CAPÍTULO 9.10

Anemia en Niños

Anemia en Niños

Diagnóstico: Puntos de corte por edad

No hay un valor fijo: se diagnostica **Anemia: Generalidades**anemia cuando Hb < **percentil 3** para la edad (equivale a -2 DE).

TABLA 9.10.1: EDAD VS HB "NORMAL" APROXIMADA	
EDAD	HB "NORMAL" APROXIMADA
Recién nacido	~15 g/dL (< 15 = anemia)
2-6 meses	Zona de anemia fisiológica (ver abajo)
> 6 meses	~11 g/dL (< 11 = anemia)

Anemia Fisiológica del Lactante

- **Rango de edad:** 2-6 meses
- Mecanismo: intercambio de Hb fetal → Hb adulta + eritropoyesis aún insuficiente
- **Punto de corte:** Hb ≥ 9 → anemia fisiológica normal (solo observar)
- Si Hb < 9 en 2-6 meses → **anemia no fisiológica** → **buscar causa**

EUNACOM CRITERIOS

Anemia fisiológica = normal y esperada. NO requiere tratamiento. El error es tratarla innecesariamente.

Causas según edad

TABLA 9.10.2: EDAD VS CAUSA MÁS FRECUENTE	
EDAD	CAUSA MÁS FRECUENTE
Recién nacido	Hemólisis por anticuerpos maternos (Rh, ABO) o alfa-talasemia
2-6 meses	Anemia fisiológica; también talasemia beta si ya inicia
> 6 meses	Anemia ferropénica (la más frecuente por lejos)

Caso especial: Déficit de B12 en lactante

- Madre vegana + **lactancia materna** exclusiva sin suplemento → posible déficit de B12 → anemia macrocítica + compromiso neurológico

Casos clínicos tipo

TABLA 9.10.3: CASO VS HB		
CASO	HB	DIAGNÓSTICO
RN, Hb 13	< 15	Anemia del RN
Lactante 3 meses, Hb 10	≥ 9	Anemia fisiológica → solo observar
Lactante 4 meses, Hb 8,5	< 9	Buscar causa (no es fisiológica)

| Lactante 12 meses, Hb 10, VCM 70 | < 11 | Anemia ferropénica → suplementar hierro |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Lactante de 6 meses, nacido de término con peso adecuado, alimentado con lactancia materna exclusiva sin suplementos previos. Acude a control de salud. La madre pregunta sobre prevención de anemia."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Prevención de Anemia Ferropénica en Lactantes (Norma MINSAL Chile): en recién nacidos de término con lactancia materna exclusiva, los depósitos fetales de hierro se agotan hacia el 4°-6° mes de vida. Se indica suplementación profiláctica universal con Hierro elemental (Sulfato ferroso gotas a 1 mg/kg/día) desde los 4 meses hasta el año de vida. En prematuros o bajo peso al nacer (< 2500g), la profilaxis se inicia antes, a los 2 meses de vida a 2-4 mg/kg/día.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El diagnóstico de anemia en niños se hace cuando la hemoglobina está bajo el percentil 3 para la edad
- Al nacer el punto de corte es ~15 g/dL; desde los 6 meses se estabiliza en ~11 g/dL
- La anemia fisiológica del lactante ocurre entre 2-6 meses; punto de corte: 9 g/dL
- Bajo hemoglobina de 9 en un lactante de 2-6 meses hay que buscar causa secundaria
- En el recién nacido: hemólisis por incompatibilidad de grupo/Rh y anemias genéticas
- Después de los 6 meses: la ferropénica es la causa más frecuente por lejos
- Déficit de B12 en niños: madre vegana con lactancia materna exclusiva sin suplementos

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANEMIA EN NIÑOS)

PREGUNTA 1

Lactante de 4 meses con hemoglobina de 8 g/dL. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Diagnosticar anemia fisiológica del lactante y observar
- B)** Buscar causa secundaria de anemia
- C)** Suplementar hierro de inmediato
- D)** Transfundir concentrado de glóbulos rojos
- E)** Solicitar electroforesis de hemoglobina

PREGUNTA 2

Recién nacido con hemoglobina de 13 g/dL. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- A)** Hemoglobina normal para un recién nacido
- B)** Anemia, ya que el punto de corte neonatal es ~15 g/dL
- C)** Policitemia neonatal
- D)** Anemia fisiológica del lactante
- E)** Requiere transfusión inmediata

PREGUNTA 3

Lactante de 12 meses con hemoglobina de 9,5 g/dL y VCM de 65 fL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Anemia fisiológica del lactante
- B)** Anemia por déficit de vitamina B12
- C)** Anemia ferropénica
- D)** Talasemia beta
- E)** Anemia hemolítica autoinmune

RESUMEN: ANEMIA EN NIÑOS

Esta clase aborda las particularidades de la anemia en niños. El diagnóstico no se hace con un punto fijo de hemoglobina sino cuando está bajo el percentil 3 (equivalente a 2 desviaciones estándar bajo la media para la edad). Al nacer, el punto de corte es aproximadamente 15 g/dL. Entre los 2 y 6 meses se produce la anemia fisiológica del lactante (recambio de sangre fetal a adulta), con un punto de corte de 9 g/dL. Bajo 9 se debe buscar una causa secundaria. Después de los 6 meses, la hemoglobina se estabiliza en torno a 11 g/dL. Las causas varían según la edad: en el recién nacido predomina la hemólisis por incompatibilidad de grupo o Rh y las anemias genéticas (alfa talasemia); entre 2-6 meses la anemia fisiológica es lo más frecuente; después de los 6 meses la ferropénica es la causa más común por lejos. Se presentan casos clínicos ilustrativos para cada rango etario.